E-Carnet — Direction artistique, branding, UI & motion

Brief enrichi à remettre à l'infographiste, designer UI/UX et motion designer · Audit du dépôt au 08/10/2026

1. Vision créative

Créer une identité qui donne immédiatement trois sensations :

- CONFIANCE — interface calme, précise, lisible, sans esthétique hospitalière froide.
- CONTRÔLE — le patient est visuellement au centre ; les autorisations sont compréhensibles et réversibles.
- TRACE — provenance, durée, établissement, action et historique doivent être représentables graphiquement.

Direction proposée : « le carnet comme espace personnel ». Le produit doit ressembler davantage à un objet numérique de confiance qu'à un portail administratif ou à une application fintech.

2. Positionnement visuel à éviter

- Croix médicale générique ou simple symbole « + » comme identité principale.
- Bouclier dominant pouvant suggérer une certification ou une garantie de sécurité.
- Imagerie de stéthoscope, blouse blanche, cœur battant ou scanner biomédical comme clichés visuels.
- Effets fintech agressifs : néons, gradients criards, glassmorphism excessif, crypto-like dashboards.
- Illustrations anxiogènes ou dramatisation de la maladie.
- Animations qui donnent l'impression que l'application analyse ou certifie une donnée médicale.

3. Architecture de marque

Élément	Proposition
Nom long	Mon Carnet Numérique
Nom court	E-Carnet
Graphie recommandée	Choisir une seule graphie officielle et l'appliquer partout.
Descripteur	Carnet de santé numérique personnel
Promesse créative	Votre santé, votre carnet, votre décision.
Territoire	Confiance · contrôle · clarté · traçabilité · humanité
Ton	Calme, direct, rassurant, jamais alarmiste ; vocabulaire simple.

À arbitrer : nom institutionnel, nom produit, casse et usage du tiret. Le design ne doit pas multiplier les versions de marque.

4. Concept logo — proposition

Concept : « la page que l'on choisit d'ouvrir ».

- Symbole basé sur une page/carnet ouvert, avec un onglet ou repère qui évoque le choix du patient.
- Une ligne, un point ou une trace peut évoquer la provenance et l'historique.
- Le symbole doit être identifiable à 16 px, fonctionner en monochrome et rester reconnaissable sans le nom.

- Éviter la croix médicale générique, le bouclier dominant et tout symbole pouvant suggérer une certification.

Livrables logo

- Symbole seul ; logo compact ; logo horizontal avec « E-Carnet » ; version institutionnelle avec « Mon Carnet Numérique ».
- Couleur, noir, blanc/inversé, niveaux de gris.
- SVG propre, source Figma/AI/SVG, PNG transparent.
- Favicon, PWA/app icon, avatar social, watermark vidéo.
- Zone de protection, tailles minimales, fonds autorisés, usages interdits.
- Version statique et animation de logo courte facultative.

5. Palette existante — inventaire exact du code

Palette active par défaut : Lagon. Le code autorise cependant neuf presets. La DA doit choisir une référence officielle pour éviter les divergences.

Preset	C1 Fond	C2 Surface	C3 Accent	C4 Primaire	C5 Encre
Sauge	#F2F5EF	#D8E2D0	#A9C4A5	#5B7F68	#2C3A33
Menthe	#E9F7F2	#BFE8D6	#63C6A7	#2F7E6A	#1F2E2C
Brume	#FFFFFF	#F4F7F8	#D6E2E6	#58B7B0	#20343A
Lagon — défaut	#E6FFF7	#B9F2E3	#7AD8C8	#4AA1A3	#2A4B5D
Miel	#FFF7E6	#FFE3B3	#FFC857	#4BAA8B	#1E3A34
Lavande	#F6F2FF	#E3D7FF	#BCA6F6	#5D64B8	#1F2440
Rose	#FFF1F5	#FFD2DF	#F28AA8	#B94D6D	#3A1E2A
Prairie	#F5FAF4	#DCEFD7	#8CCF8A	#2F8A5A	#1F2D24
Argile	#FFF4EC	#F6D8C3	#DDA57A	#4D8F86	#1D2F33

Recommandation DA : Sauge & encre

- Fond très clair et respirant.
- Vert sauge comme repère de soin, mais sans ressembler au vert médical institutionnel.
- Encre profonde pour les titres, actions majeures et repères de confiance.
- Accent doux pour les surfaces et états secondaires.
- Couleurs sémantiques séparées de la marque.

6. Couleurs sémantiques — ne pas les détourner

État	Texte	Fond
Déclaré / en attente	#8A6100	#FFF3D6
Mesuré / relevé	#1F4E8C	#E6EEF8
Confirmé / validé / actif	#17704A	#E4F5EC
Contesté / refusé / erreur	#A32D2D	#FBEAE8
Expiré / révoqué / suspendu	#4A5550	#E8ECE9
Danger	#A32D2D	—

Règle : la couleur ne doit jamais être le seul porteur d'information. Toujours associer libellé + icône/forme + structure.

7. Typographie — inventaire du code

Famille	Présente dans le code	Recommandation
Plus Jakarta Sans	Oui	CHOIX PRIORITAIRE pour la production.
Nunito	Oui	Alternative chaleureuse.

Lexend	Oui	Option accessibilité/lecture.
Manrope	Oui	Alternative moderne sobre.
Sora	Oui	Accent / test, moins prioritaire pour longs textes.
Mooli	Oui	À réserver si besoin créatif.
Unbounded	Oui — défaut actuel	Ne pas utiliser comme police principale de lecture sans tests approfondis.
Quicksand	Oui	Alternative arrondie.
Bricolage Grotesque	Oui	Accent/headlines éventuels.
Barlow	Oui	Alternative fonctionnelle.
Ubuntu	Oui	Alternative secondaire.
Fredoka	Oui	À éviter pour le corps ; caractère très marqué.
JetBrains Mono	Oui	Uniquement codes/identifiants/repères techniques.

Système recommandé

- Police principale : Plus Jakarta Sans.
- Corps : 16 px minimum dans les parcours de lecture ; interligne confortable.
- Titres : 700/800 selon niveau ; éviter l'excès de capitales.
- Labels : 13–14 px minimum en interface.
- États/pastilles : environ 12–13 px, jamais comme seul signal.
- Codes/identifiants/eyebrow techniques : JetBrains Mono.
- Une seule famille principale en production ; les 12 familles peuvent rester comme expérimentation tant que le produit n'est pas figé.

8. Formes, rayons et surfaces

Token observé	**Valeur**
Petit rayon	10 px
Rayon moyen	16 px
Grand rayon	22 px
Pilule	999 px
Cible tactile minimale	44 px
Ombre légère	0 1px 2px rgba(42,75,93,.08)
Ombre moyenne	0 10px 30px -14px rgba(42,75,93,.35)
Hauteur nav	68 px

- Cartes : surfaces blanches, bordure discrète, rayon moyen/grand.
- Actions principales : formes nettes, hauteur tactile confortable.
- Pas de surabondance de cartes imbriquées.
- Favoriser espaces blancs, hiérarchie et respiration plutôt que décoration.

9. Iconographie

- Grille standard 24 × 24.
- Trait 1.8 px, terminaisons et angles arrondis.
- Style linéaire cohérent.
- Jeu actuel : accueil, dossier, stéthoscope, partage, utilisateur, utilisateurs, cloche, validation, verrou, identité, cœur, plus, déconnexion, recherche, caméra, bâtiment, lien, graphique, localisation, aide, bouclier, QR, document, crayon, horloge, e-mail, alerte, œil, fermeture, sparkle.
- Remplacer progressivement les glyphes Unicode restants par le système SVG commun.
- Les logos Google/Facebook/Apple restent des assets de marque séparés.

10. Grille UI / composition

- Mobile-first : information et actions atteignables au pouce.
- Navigation patient actuelle : Accueil · Carnet · Consult. · Accès · Moi.
- Desktop : rail latéral + en-tête.
- Largeur publique observée : environ 1120 px.
- Landing : hero en deux colonnes à partir de ~920 px ; cartes en grille à partir de ~720 px.
- Conserver une grille stricte, des alignements communs et une hiérarchie verticale nette.
- Éviter les interfaces « dashboard entreprise » trop denses : E-Carnet doit rester personnel.

11. Direction illustration

- Illustrer une personne qui prépare son carnet, choisit un destinataire, définit un périmètre et retrouve une trace.
- Objets visuels : page, onglet, lien, point, timeline, carte d'accès, QR, enveloppe, bâtiment.
- Privilégier formes géométriques douces et scènes humaines simples.
- Éviter l'imagerie médicale cliché.
- Représenter des personnes diverses sans folklorisation de l'Afrique de l'Ouest.
- Créer un petit langage graphique réutilisable en landing, onboarding, FAQ, réseaux sociaux et vidéos.

12. Direction photographie

- Si photo : lumière naturelle, gestes réels, cadrages rapprochés, environnement quotidien.
- Éviter les photos de banques d'images avec blouse blanche souriante face caméra.
- Montrer relation, autonomie et confiance plutôt que maladie.
- Utiliser la photo comme ponctuation ; l'identité doit pouvoir fonctionner sans photo.

13. Infographie et data visualisation

- Créer des diagrammes simples de flux : Patient → demande → choix → accès → historique.
- Créer une représentation claire des périmètres d'accès.
- Timeline pour l'historique.
- Badges pour provenance et statut.
- Ne jamais utiliser de graphiques pour suggérer une analyse clinique non réalisée.
- Échelle, légende et libellés toujours présents.

14. Motion design

Principe : le mouvement explique un état ; il ne doit jamais simuler une capacité médicale ou une certification.

Moment	**Motion proposée**
Préparation	Progression douce brouillon → clôture ; apparition de la provenance.
Demande d'accès	Carte qui arrive ; professionnel, établissement, périmètre et durée visibles.
Choix patient	Transition neutre entre autoriser/refuser ; aucun choix visuellement valorisé.
QR	Apparition nette du QR + expiration ; pas d'effet de scan trompeur.
Accès actif	Badge et durée se mettent à jour de façon discrète.
Révocation/expiration	Transition d'état sobre, avec texte explicite.
Historique	Nouvelle ligne qui s'insère dans la timeline.

Logo	Animation courte facultative, lente et lisible, sans son obligatoire.

- Point de départ : 120–200 ms pour micro-transitions, à tester.
- Respecter prefers-reduced-motion.
- Pas de flash, clignotement ou urgence décorative.
- Ne jamais communiquer un statut uniquement par le mouvement.
- Pas de battement de cœur, scan biomédical, dossier qui « pense », ou données qui se propagent comme si elles étaient analysées.

15. Système de motion à livrer

- Courbes/easing, durées, distances, règles d'entrée/sortie.
- Transitions d'autorisation et de rattachement.
- QR et expiration.
- États loading, success, error, revoked, expired.
- Animation logo facultative.
- Version réduite sans mouvement.
- Exports Lottie/SVG/vidéo selon les usages.

16. Écrans prioritaires pour la DA

1. 1. Landing publique et identité.
2. 2. Connexion / inscription / onboarding.
3. 3. Accueil patient.
4. 4. Déclaration / pré-consultation.
5. 5. Demande d'accès et autorisation.
6. 6. QR.
7. 7. Historique patient.
8. 8. Profil professionnel et rattachement.
9. 9. Demande établissement : acceptation/refus.
10. 10. Espace administrateur établissement.
11. 11. États transversaux : vide, loading, erreur, hors réseau, session expirée, refus, expiration, révocation, succès.
12. 12. FAQ, sécurité, conditions de rattachement.

17. Kit de marque / livrables infographiste

- Logo complet + symbole.
- Palette officielle avec valeurs HEX/RGB/HSL et règles d'usage.
- Typographie : familles, graisses, tailles, interlignage, fallback.
- Grille, espacements, rayons, ombres.
- Jeu d'icônes et règles d'illustration.
- Bibliothèque de composants Figma.
- Templates réseaux sociaux : 1:1, 4:5, 9:16, 16:9.
- Template présentation produit / screenshots.
- Template infographie « comment ça marche ».
- Template citation/témoignage, FAQ, sécurité et annonces.
- Guide d'usage de marque PDF/figma.

18. Kit motion / vidéo

- Intro/outro 3–5 s.

- Animation logo.
- Transitions.
- Pack de lower thirds.
- Titres / sous-titres.
- Animations des flux Patient → Professionnel → Établissement.
- Démo QR / autorisation.
- Version verticale 9:16 et horizontale 16:9.
- Version silencieuse sous-titrée.
- Version reduced-motion / statique pour documentation.

19. Direction finale proposée

« Le carnet comme espace personnel : doux comme un objet de soin, rigoureux comme une trace administrative, simple comme une décision. »

Sauge + encre profonde, Plus Jakarta Sans, icônes linéaires 24 px, cartes respirantes, illustrations éditoriales minimalistes et motion courte. L'identité doit être chaleureuse sans devenir ludique, médicale sans devenir hospitalière, technique sans devenir fintech.

20. Points à verrouiller avec le produit avant exécution

- Nom officiel : Mon Carnet Numérique vs E-Carnet.
- Logo propriétaire : abandon du « + » générique comme symbole principal.
- Palette officielle : recommandation Sauge & encre vs Lagon actuellement actif.
- Police officielle : recommandation Plus Jakarta Sans vs Unbounded actuellement actif.
- Thème personnalisable par utilisateur : conserver ou non dans la V1.
- Statut public du produit : pilote fictif / NO-GO pour données réelles.
- Vocabulaire de confiance : « vérifié », « sécurisé », « validé », « certifié ».
- Scope et terminologie des autorisations.
- Version finale des textes après revue juridique et médicale.

21. Fichiers sources graphiques inspectés

- packages/ui/src/styles/tokens.css
- packages/ui/src/themes.ts
- apps/api/apps/identity/theme.py
- apps/web/src/app/globals.css
- apps/web/src/app/landing.css
- apps/web/src/app/layout.tsx
- apps/web/src/components/ui/Icon.tsx
- apps/web/src/components/ThemeSettingsClient.tsx
- docs/prototypes/README.md
- docs/prototypes/ARCHITECTURE.md
- docs/prototypes/themes.ts
- docs/prototypes/tokens.css